

Практичні навички (прості) за фахом «Внутрішня медицина»

1. Чек-лист до практичної навички «Вимірювання пульсу на променевих артеріях»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи або сидячи навпроти пацієнта), встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль).	Виконати/Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Взяти обидві руки пацієнта і охопити їх зверху в ділянці променево - зап'ясткових суглобів так, щоб пучки других, третіх та четвертих пальців опинилися зверху з долонного боку на променевій артерії.	Виконати
5	Пропальпувати артерії на обох руках. Якщо пульсові хвилі синхронні (симетричні) на обох руках, одну руку відпустіть і продовжуйте визначення всіх характеристик пульсу на одній руці.	Виконати/ Сказати
6	Визначати наступні характеристики: • ритм; • частоту (у разі ритмічної діяльності за 15 секунд, у разі аритмічної діяльності 1 хвилину); • наповнення; • напруження	Сказати/Виконати
7	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

2. Чек-лист до практичної навички «Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
		представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Нанести гель або воду на місце постановки електродів	Виконати

5	Коректне накладання 4 пластинчатих (стандартних) електродів: - червоний - права верхня кінцівка - жовтий - ліва верхня кінцівка - зелений - ліва нижня кінцівка - чорний - права нижня кінцівка	Виконати
6	Коректне накладання грудних електродів: 1-й – 4 м/р біля краю грудини справа; 2-й - 4 м/р біля краю грудини зліва; 4-й – 5 м/р по середньо-ключичній лінії зліва; 3-й – по середині між 2-м та 4-м електродами; 5-й – 5 м/ по передній пахвинній лінії; 6-й - 5 м/ по середній пахвинній лінії.	Виконати
7	Реєстрація ЕКГ	Виконати
8	Зняття стандартних і грудних електродів з пацієнта	Виконати
9	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

3. Чек-лист до практичної навички
«Вимірювання артеріального тиску методом Короткова»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Обробити акустичну мембрану фонендоскопу розчином антисептика	
5	Коректно (на рівні серця) розташувати руки пацієнта та перевірити манометр	Виконати
6	Коректне (на оголене плече, нижній край манжети розташувати на 2-3 см вище за ліктьовий згин) накладання манжети	Виконати
7	Коректно (центр ліктьової ямки) розташувати акустичну голівку фонендоскопа	Виконати

8	Накачати повітря у манжетку	Виконати
9	При стравлюванні повітря з манжетки зафіксувати рівень систолічного (поява першого тону Короткова) та діастолічного (зникнення тонів Короткова) артеріального тиску	Виконати / Сказати
10	Зняття манжети	Виконати
11	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

4. Чек-лист до практичної навички
«Аускультация сердца»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитись, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Обробити акустичну мембрану фонендоскопу розчином антисептика	Виконати
5	Пальпаторно визначити місце верхівкового поштовху	Виконати
6	Аускультация сердца в коректній послідовності: - перша точка - над верхівкою серця - друга точка - II міжребер'я справа від груднини - третя точка - II міжребер'я зліва від груднини -четверта точка - біля основи мечоподібного відростка груднини - п'ята точка – 4 міжребер'я зліва від груднини	Виконати
7	Визначити характеристику серцевих тонів: • ритм; • гучність; • наявність розщеплення або додаткових тонів серця; • наявність серцевих шумів.	Сказати
8	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

5. Чек-лист до практичної навички
«Аускультация легень»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
------	-------------	---------------------

1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Обробити акустичну мембрану фонендоскопу розчином антисептика	Виконати
5	Аускультация легень: симетричність (аускультацию проводити на симетричних ділянках грудної клітки, у кожній точці аускультации вислуховувати 2-3 дихальних цикли).	Виконати
6	Аускультация легень: коректна послідовність спереду (у місці розташування серця легені не вислуховувати)	Виконати
7	Аускультация легень: коректна послідовність в пахвинних ділянках (при аускультации в бічних відділах просять хворого поставити руки на пояс)	Виконати
8	Аускультация легень: коректна послідовність позаду (при вислуховуванні ззаду просять злегка нахилитися вперед і схрестити руки на грудях (для розбіжності лопаток)	Виконати
9	Аналіз основних та побічних дихальних шумів	Сказати
10	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

6. Чек-лист до практичної навички
«Перкусія серця (визначення меж відносної тупості серця)»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати

4	Перкусія правої межі відносної тупості серця по відповідним лініям: палець-плесиметр ставлять в III міжребер'ї паралельно ребрам по правій серединно-ключичній лінії, використовують голосну перкусію й просуваються вниз до зміни перкуторного звуку від ясного легеневого (легені) до тупого звуку (печінка) У нормі нижня межа правої легені перебуває в VI міжребер'ї. Палець-плесиметр пересувають на міжребер'є вище, міняють його положення, тобто ставлять паралельно до грудини. Змінюється сила перкусії – тиха, топографічна. Перкусія проводиться в напрямку грудини до зміни перкуторного звуку від ясного легеневого до притуплення.). У нормі в здорової людини права межа відносної тупості серця перебуває в IV міжребер'ї на 1 см назовні від правого краю грудини.	Виконати/Сказати
5	Перкусія верхньої межі відносної тупості серця по відповідній лінії: палець-плесиметр необхідно покласти в I міжребер'є по лівій білягрудинній лінії й перкутувати вниз до зміни перкуторного звуку. У нормі верхня межа відносної тупості серця розташована в III міжребер'ї по лівій білягрудинній лінії.	Виконати/Сказати
6	Перкусія лівої межі відносної тупості серця по відповідній лінії: знайти верхівковий поштовх, який співпадає з лівою межею. Перкусію починають у тому ж міжребер'ї, у якому перебуває верхівковий поштовх, починаючи з лівої середньо-пахвової лінії. Палець-плесиметр розташовують паралельно грудині й уздовж міжребер'я перкутують у напрямку до грудини до притуплення. У нормі ліва межа відносної тупості серця розташована в V міжребер'ї на 1-1,5 см досередини від лівої серединно-ключичної лінії.	Виконати/Сказати
7	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

7. Чек-лист до практичної навички
«Порівняльна перкусія легень»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати

4	Порівняльна перкусія легень: симетричність (визначають характер звуку в кожній точці перкусії й порівнюють його з перкуторним звуком на протилежній стороні, а також зі звуком на сусідніх ділянках легенів).	Виконати
5	Порівняльна перкусія надключичних ділянок (палець-плесиметр ставиться паралельно ключиці)	Виконати
6	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність спереду: передня поверхня грудної клітки (праворуч перкусія проводиться до зміни перкуторного звуку над усією половиною грудної клітки, а ліворуч – з урахуванням відносної серцевої тупості). Перкусія проводиться по середньоключичним лініям і вирівнюється до рівня 3 міжребер'я (далі проводиться тільки праворуч).	Виконати
7	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність в пахвинних областях(при цьому хворий ставить руки на пояс).	Виконати
8	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність позаду: у надлопаткових областях палець перебуває в горизонтальному положенні, у міжлопатковому просторі – у вертикальному положенні, під лопатками – знову горизонтально.	Виконати
9	Оцінка перкуторного звуку над всією поверхнею легень	Сказати
10	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

8. Чек-лист до практичної навички

«Поверхнева пальпація щитовидної залози»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар (лікар стоїть перед хворим), встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитись, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Ліва рука укладається ззаду на шию пацієнта з метою фіксації тіла і голови - великий палець на передній поверхні шиї, інші пальці на задній поверхні шиї.	Виконати
5	Права рука лікаря укладається на область щитовидної залози - від середини щитовидного хряща вниз, і ковзаючим рухом обмацує передню поверхню шиї до яремної вирізки.	Виконати

6	Перекочуючись кінчиками пальців через перешийок, визначає його ширину, консистенцію, рухливість при ковтанні. Після цього в борознах, утворених бічними поверхнями щитовидного хряща і внутрішніми краями кивальних м'язів, безпосередньо над верхнім краєм перешийка намагаємося намацати бічні частки залози. Пальпують зімкнутими кінчиками вказівного, середнього та безіменного пальців правої руки спочатку з одного боку, а потім - з іншого. Напрямок пальпації - від щитовидного хряща до кивального м'яза	Виконати
7	Визначити характеристики щитовидної залози: • температуру шкіри над залозою; • орієнтовну величину залози, її часток; • характер поверхні залози; • щільність органу; • наявність великих вузлів; • наявність судинної пульсації і треміння; • болючість залози	Сказати
8	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

9. Чек-лист до практичної навички
«Перкусія печінки за методом Курлова»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування лікар-пацієнт, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Перший розмір. Верхня межа: коректна перкусія по правій середньо-ключичній лінії, визначити точки переходу ясного легеневого звуку в тупий печінковий	Виконати
5	Нижня межа: коректна перкусія по правій серединно-ключичній лінії від пупка вгору до визначення точки переходу тимпанічного звуку в тупий. Поєднавши дві точки, виміряти перший розмір печінки за методом Курлова, що зазвичай становить 9 см.	Виконати
6	Другий розмір. За верхню межу цього розміру умовно	Виконати
	приймають точку, що лежить на одному рівні з верхньою межею першого розміру печінкової тупості (через цю точку проводять горизонталь до перетину з серединною лінією)	

7	Нижня межа: коректна перкусія по серединній лінії живота до появи печінкової тупості. З'єднавши ці точки, вимірюють другий розмір печінки за методом Курлова, що зазвичай становить 8 см	Виконати
8	Третій розмір. Верхня межа відповідає верхній точці другого розміру печінки. Нижня межа: коректна перкусія поблизу лівої реберної дуги перпендикулярно до неї, починаючи перкусію приблизно з передньої пахвової лінії. З'єднавши ці точки, вимірюють третій розмір печінки за методом Курлова, що зазвичай становить 7 см.	Виконати
9	Розміри печінки по Курлову	Сказати
10	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

10. Чек-лист до практичної навички
«Поверхнева пальпація живота»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування лікар-пацієнт (горизонтально), встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Коректне проведення поверхневої орієнтовної пальпації (лікар свою долоню кладе пласко на живіт пацієнта і проводить легкі, обережні натискання м'якушем нігтьових фаланг пальців, переміщуючи на 3-4 см в боки послідовно (проти часової стрілки): ліва здухвинна ділянка, ліва бокова ділянка, ліве підребер'я, епігастральна ділянка, праве підребер'я, права бокова ділянка, права здухвинна ділянка, навколупупкова ділянка, надлобкова ділянка	Виконати
5	Дослідження білої лінії живота (просять пацієнта, який перебуває в горизонтальному положенні, підняти голову, відірвавши її від подушки без допомоги рук, а лікар у цей час проводить своїм вказівним пальцем по середній лінії живота нижче мечоподібного відростка)	Виконати
6	Оцінка напруження, резистентності, болючості передньої черевної стінки, розходження прямих м'язів живота. Наявність вільної рідини.	Сказати

7	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати
---	--------------------------------------	---------

11. Чек-лист до практичної навички
«Пальпація лімфатичних вузлів»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування лікар-пацієнт, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Візуальне оцінювання стану лімфатичних вузлів (в нормі не візуалізуються)	Сказати
5	Коректна пальпація лімфатичних вузлів (кінчиками пальців зробити ковзні кругові рухи в області передбачуваної локалізації лімфатичних вузлів)	Виконати
6	Коректна послідовність пальпації лімфатичних вузлів (потиличні, завушні, підборіддя, підщелепні, передньошийні, задньошийні, надключичні, підключичні, пахові, ліктьові, пахові, підколінні)	Виконати
7	Оцінювання характеру лімфатичних вузлів (в нормі не пальпуються): -локалізація; -розмір; -консистенція; -болючість; -зміщення (по відношенню до шкіри і оточуючих тканин); -зміна шкіри над лімфатичними вузлами.	Сказати
8	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

12. Чек-лист до практичної навички
«Симптом Пастернацького»

№п/п	Маніпуляція	Форма представлення

1	Коректне розташування лікар-пацієнт (вертикально), встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформовану згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Визначення больових відчуттів в поперековій області зліва (лікар кладе свою одну руку на область XII ребра ліворуч від хребта і здійснює що до неї короткі удари другою рукою, стиснутою в кулак).	Виконати
5	Визначення больових відчуттів в поперековій області справа (лікар кладе свою одну руку на область XII ребра праворуч від хребта і здійснює що до неї короткі удари другою рукою, стиснутою в кулак).	Виконати
6	Визначити «позитивний» чи «негативний» симптом Пастернацького	Сказати
7	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати